

19 - 07- Énurésie - Pr. Aït Sab

L'aneurysie chez l'enfant. L'étudiant doit être capable de connaître la définition de l'aneurysie, de savoir mener l'interrogatoire d'une aneurysie, de différencier l'aneurysie primaire monosymptomatique ou l'ENPI des autres aneurysies secondaires et électromyctionnelles, de poser le diagnostic de l'ENPI, et de connaître les principes et indications des différents traitements de l'ENPI. L'aneurysie par définition nocturne est à différencier par l'interrogatoire électromyctonique des autres pertes d'urines qui n'ont pas les mêmes caractéristiques et s'accompagnent généralement d'autres symptômes, comme un cystique, une infection urinaire, une dysurie, une incontinence oeuvrée.

L'aneurysie se distingue aussi de l'immaturité physique et se caractérise par des mictions impérieuses, dures, avec fuite possible, mais paradoxalement, rarement nocturnes. Une fois le remplissage végétal est atteint, alors une pression supérieure à 20 cm d'eau, la vessie déclare qu'elle est bien pleine, et donc, elle demande à faire pied. Par sécurité, j'augmente la tonicité des sphincters pour ne pas faire pied-pied le soir.

Le volume urinaire et la capacité végétale entraînent une vessie pleine, alors dès que la vessie est pleine, c'est une alerte, et donc l'enfant se réveille pour faire sa mixtion. Une mixtion normale se fait après une ouverture du périmètre, ouverture des sphincters, contraction du décret cruseur, décontraction du trésor, fermeture du sphincter, puis fermeture du périmètre. C'est une commande optimisée, donc il y a un arc-reflexe médulaire, puis après, il y a une intégration vulvaire du réflexe mixtionnel jusqu'à l'âge de 2 ans, et donc on parle là d'une mixtion automatique au moins de 2 ans, et puis après l'âge de 2 ans, il y a un contrôle cortical des centres vulvaires, et donc la mixtion devient volontaire le jour après 2 ans et la nuit vers l'âge de 5 ans.

Dans l'archéologie des troubles mixtionnels de l'enfant, d'abord, les troubles mixtionnels, ce n'est pas une inconstance permanente, on parle quand il y a une inconstance permanente, ce n'est pas les troubles mixtionnels. Une inconstance permanente, quand on a des anomalies des organes génitaux, une dyshémologie, etc., ce n'est pas les troubles mixtionnels. Troubles mixtionnels se distinguent en deux, soit les troubles mixtionnels primitifs ou les troubles mixtionnels secondaires.

Les troubles mixtionnels primitifs, c'est l'aneurysie, dont sa forme primitive ou secondaire. On parle d'une incontinence intermittente. Soit c'est des troubles mixtionnels secondaires, une mauvaise position, une irritation physique par une infection oédipiaire, une constipation ou des troubles psychiatriques.

Et dans les troubles mixtionnels primitifs, il y a une dysfonction physique primitive, c'est ce qu'on appelle l'incontinence intermittente dure plus ou moins longtemps. Qu'est-ce que la définition selon l'incontinence dure plus ou moins longtemps ? L'incontinence dure plus ou moins

longtemps signifie une sorte d'urine incontrôlable. L'incontinence peut être permanente ou intermittente.

L'aneurysie nocturne est définie par la présence de miction nocturne involontaire et inconsciente survenant à un âge où la propreté est généralement acquise, c'est-à-dire après l'âge de 5 ans. C'est une incontinence intermittente pendant le sommeil. Le terme d'aneurysie dure est ombragée et doit être évité.

L'aneurysie est dite primaire si l'enfant n'a jamais eu de période de continence durant le sommeil dont moins 6 mois. La reprise d'une incontinence pendant le sommeil après 6 mois de contrôle mictionnel est une aneurysie secondaire. L'aneurysie primaire est dite isolée ou monosymptomatique s'il n'existe aucun autre symptôme ou particulier dure relevant du bas appareil urinaire.

Différencier l'aneurysie d'une aneurysie nocturne monosymptomatique, d'une aneurysie secondaire, à un automatisme urovisical acquis mais perdu à l'occasion d'un événement perturbateur, parfois évident, un échec ou une troubles scolaires, une mésentente ou une séparation des parents, une naissance d'un frère ou d'une soeur, et un d'autre. Les troubles mictionnels fonctionnels, c'est une rétention sphérocortale, infection urinaire, instabilité physique, instabilité uréthrale ou syndrome de Himmel. Diagnostic différentiel, une neuropathie malformative, crise neurologique, encéphalopathie, polyurie, secondaire, un diabète, ainsi.

L'aneurysie se trouve pour le NPI, qui est une entité pathologique avec une définition triste. Son diagnostic est purement clinique par exclusion de tous les autres troubles mictionnels, en particulier durs. L'incidence réelle de le NPI est actuellement inconnue.

Le N affecte 7,3 à 11,2 % des enfants à l'âge de 7 ans, mais persiste chez 1 % des adultes. Souffrance médicale, prévalence de l'aneurysie primitive de 9,2 %. L'affection a tendance à guérir spontanément avec un taux de l'ordre de 15 % par an. C'est un concept selon lequel tous les aneurysiques seront guéris à la puberté et faux, et l'aneurysie existe chez l'adulte.

Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les aneurysiques ne vont pas guérir vers l'âge de la puberté, parce qu'il y a des adultes. 1 % des aneurysiques vont garder une aneurysie jusqu'à l'âge adulte. La définition de l'aneurysie primitive est monosymptomatique, exclus d'un ou de certains suivants.

Une fréquence anorale de miction qui peut être trop fréquente, plus de 8 fois par jour, ou trop rare, moins de 3 fois par jour. Une incontinence dure, une impériosité mictionnelle non-contenue, des faux besoins, un effort de poussée à la miction, faiblesse du G ou un G saccadé, manœuvre de retenue, accroupissement, verge pincée, jambes croisées ou agitation, sensation de vidange visuelle incomplète ou goutte résiduelle, cystalgie ou douleur génitale. Il faut toujours rechercher ça par un interrogatoire ou un questionnaire à remplir à domicile.

Sinon, il s'agit de troubles visicaux primitifs ou secondaires. Soit il y a un défaut des veilles nocturnes mixionnelles, soit il n'y a pas de déclenchement de la vidange, soit il n'y a pas de déclenchement de la vidange. du carrefour ORL qui favorisent une poliurie par l'hypercapnée et leur traitement peut améliorer l'énergie.

La forme à faible capacité physique définie, c'est-à-dire réduction de 70% de la capacité fonctionnelle, évaluée sur un calendrier émissionnel de 48 heures, généralement cette forme d'énergie est réfractaire à l'hémorragie ou à l'hypercapnée. La forme à faible capacité physique définie, c'est-à-dire réduction de 70% de la capacité fonctionnelle, évaluée sur un calendrier l'hémorragie ou à l'hypercapnée. La forme à faible capacité physique définie, c'est-à-dire réduction de 70% de la capacité fonctionnelle, généralement cette forme réduction de 70% de la capacité fonctionnelle à démissionner dans le cadre d'un L'aneurysie peut être associée à des troubles de déficit de l'attention et hyperactivité.

20% des enfants qui souffrent de ces troubles ont une aneurysie primitive, et 10% des aneurysiques primitifs souffrent de troubles avec déficit de l'attention et hyperactivité, donc c'est une comorbidité à rechercher. La baisse de l'estime de soi est un symptôme psychique fréquent chez les enfants aneurysiques, et les perturbations de la vie familiale et sociale sont aussi fréquentes. C'est une réalité qui justifie la prise en charge parce qu'il y a un dysfonctionnement de la relation enfant-pape.

Il constitue une sorte de honte et de culpabilité pour l'enfant, mais il ne faut pas grandir. Il faut surtout expliquer et inciter à responsabiliser l'enfant. Quelle orientation diagnostique devant une aneurysie maxime primaire isolée ? Diagnostic positif de l'aneurysie primitive isolée est avant tout clinique.

Il repose sur l'interrogatoire et l'examen physique au cours d'une consultation initiale, nécessairement devant l'hôpital. À l'hôpital de France, il faut chercher la fréquence de l'accident nocturne, la quantité et la répartition des boissons, les habitudes mixionnelles et transites intestinales s'il y a une constipation, exclure un dysfonctionnement physical, donc chercher cette notion de fuite dure, d'accroissement, etc. Est-ce qu'il n'y a pas de période de continence nocturne de moins de 6 mois consécutifs sans traitement, qui donne à cette aneurysie le caractère primitif ? Établir un calendrier mixionnel sur 48 heures pour apprécier l'absence de troubles mixionnels, chercher un retentissement familial et social, apprécier la motivation de l'enfant et de ses parents, et chercher un déficit de l'attention.

Et il faut après définir l'intensité de l'aneurysie primitif isolée, comme étant modérée s'il y a en moyenne moins d'un épisode par semaine, moyenne s'il y a en moyenne un à deux épisodes par semaine, ou sévère quand il y a au moins trois épisodes par semaine. On demande à l'enfant de consigner sur le calendrier quand et l'urine, et chaque fois que possible, mesurer la quantité d'urine émise. Noter les nuits sèches et mouillées, mesurer occasionnellement la production nocturne d'urine, peser les couches, le poids de la couche, plus le volume d'urine émise au réveil,

ça nous donne un résultat approché en millilitres, ça nous donne la quantité ou la production nocturne d'urine en millilitres.

Et il faut quantifier s'il ne fait qu'une tâche, une croix, s'il est mouillé, c'est deux croix, et s'il est trompé, c'est trois croix. Ce sont des exemples du calendrier qu'on donne à l'enfant pour remplir chez lui, pour voir ça après, pour sa deuxième consommation. Il faut toujours éliminer une bonne mixtion, une bonne position, une bonne décontraction avec bon appui et jambes ouvertes.

Il faut éliminer alors une mauvaise position, les jambes serrées, les toilettes qui sont grandes et les vêtements sains. Éliminer aussi les troubles mixtionnels secondaires à une irritation physique, comme les lésions, les spas, blots, infections, l'irritation des organes génitaux externes par une vulvite, des pertes, adhérences, irritation, du méa. Ou des anomalies psychiatriques, pathologies lourdes, avec oncoprénie, qui sont très rares, mais qui sont évidentes, et il faut envoyer l'enfant vers un pédopsychiatre.

Rechercher des troubles mixtionnels et constipation. On dit que la vie-ci fonctionne bien avec un rectum vide. La constipation peut participer au trouble physique, ou la constipation peut accompagner le trouble physique dans un trouble sphinctérien plus complexe.

Il faut rechercher quand il y a association de troubles mixtionnels et de constipation. Il faut rechercher de façon attentive. Il faut faire un examen de rachis.

Surtout si la constipation et les troubles mixtionnels sont quotidiens, il faut faire un traitement urologique et un traitement de vie de la constipation. Pour bien sûr la différencier des autres troubles mixtionnels chez l'enfant. Il faut faire l'observation du comportement de l'enfant, sa motivation, est-ce qu'elle est agitée, est-ce qu'elle a des troubles de l'attention.

Observer une mixtion si possible. Palper l'abdomen à la recherche d'un encombrement intestinal ou d'un gros physique, qui n'est pas du tout orientateur vers une anurie primitive isolée. Il faut faire un examen de la région dorsale et sacrée, rechercher des anomalies rachidiennes ou des racines nerveuses.

L'examen neurologique, l'étude de la marche, la route volontaire, la trophicité musculaire et les réflexes pour éliminer les troubles neurologiques qui sont responsables des troubles mixtionnels. Examiner les organes génitaux externes, l'oméa urétrale chez la fille comme chez le garçon. Et à la fin, mettre un bandelette réactive dans les urines pour exclure une infection, un diabète par la présence d'une glycosurie, une hyperconcentration des urines de la journée, voire la densité urinaire.

Une fois les autres troubles mixtionnels éliminés, en l'occurrence des troubles mixtionnels primitifs, c'est une fois une anurie primitive isolée ou une anurie secondaire, et donc c'est une incontinence intermittente qui est uniquement nocturne. Le diagnostic positif d'une anurie primitive isolée, c'est un diagnostic clinique. Aucune imagerie ou examen complémentaire n'est

nécessaire en première intention pour le diagnostic.

Il repose uniquement sur les données de l'interrogatoire et sur ce qu'il faut traiter ou pas. Durant la première consultation, il faut informer le malade et sa famille ou l'enfant et sa famille et faire une éducation concernant la mixtion, comment faire la mixtion, les règles, des règles hygiénologiques éthiques, et établir à domicile un calendrier mixtionnel montré à l'enfant comment le faire. Alors, pour un enfant hémorragique, il faut limiter les apports d'épuisement.

45 à 60 ml par kilo. Par exemple, chez un enfant qui a 7 ans qui pèse 20 kilos, il faut 1000 ml par jour. Il faut dire à cet enfant qu'il doit consommer, durant la journée, les 1000 ml vers 18 heures et il faut stopper les apports liquidiens.

Il faut aussi encore encourager un rythme mixtionnel qui est adapté et un transit intestinal normal. Donc, il faut dire à l'enfant de faire 5 à 6 mixtions par jour et bien sûr, il faut toujours faire une mixtion avant le coucher et traiter toute constipation parce que le traitement de la constipation peut améliorer une aneurysie dans 63 % des cas. Après, il faut faire un calendrier mixtionnel.

Il faut suivre les conseils pendant au moins deux semaines et remplir un calendrier d'accès dans la nourriture ou s'en monter l'huile sèche et mouillée. Cette évaluation initiale est très importante pour l'enfant. Alors, le calendrier, on va mettre sur le calendrier de l'huile mouillée par rapport à l'huile sèche.

Comme ça, si on a plus de huile sèche, ça va encourager l'enfant à continuer ses règles hygiénogénétiques et évaluer ça sur 48 heures. Donc, on évalue le nombre et le volume des mixtions dures et le volume et les fuites nocturnes. Ça veut dire qu'on pèse les couches et qu'on pèse le pipi du matin pour voir le volume de la mixtion nocturne.

Pour les traitements spécifiques, les patients motivés ou non guéris par les seules contractions hygiénogénétiques devraient recevoir un traitement spécifique pour leur énergie primitive isolée. Le traitement initial devrait être proposé à partir de 6 ans en fonction du type de l'énergie primitive isolée. Alors, on propose la dysmopression, un comprimé à partir de 0,2 mg ou un lyophilisat à partir de 120 mg.

Et le traitement de choix dans l'énergie primitive isolée est associé à une polyurie nocturne et réfractaire aux seules mesures hygiénogénétiques. Mais bien sûr, pour les règles de bon usage de la dysmopression, il faut faire une restriction stricte de l'eau, surtout après la prise des comprimés ou du lyophilisat. La deuxième alternative, c'est les systèmes d'alarme avec un suivi comportemental et un soutien de la motivation familiale.

C'est un système qui est lié à la culotte de l'enfant et qui lance une alarme dès que les premières gouttes d'urine sont perçues au niveau de la culotte de l'enfant et ça fait réveiller l'enfant pour aller terminer sa mission aux toilettes. Il y a aussi l'oxybutyline qui est un antichol énergétique. C'est un traitement de seconde intention en monothérapie si échec du traitement spécifique et si

on a une faible capacité physique nocturne ou une vessie hyperactive pendant le sommeil.

Il y a d'autres traitements combinés. Certaines énergies sont en rapport à une monothérapie. Chez ces patients, on peut proposer d'autres traitements combinés comme par exemple la dysmopression et alarme, la dysmopression et oxybutyline ou alarme et oxybutyline.

Les antidépresseurs tricycliques étaient utilisés pendant longtemps dans le traitement d'énergie primitive isolée mais ils ne doivent pas être prescrits sauf cas exceptionnels. Il y a d'autres types de traitements comme l'hypnose, la psychothérapie, etc. qui ne sont pas actuellement validés chez l'enfant.

En conclusion, l'énergie primitive isolée a une définition stricte. C'est une énergie nocturne. Son diagnostic est purement clinique par exclusion de tous les autres troubles mixtionnels, en particulier d'urine.

Deux formes différentes en fonction de sa cause dominante, soit une polyurie nocturne ou une petite capacité visible. Les troubles associés doivent être recherchés et la prise en charge comporte une base commune qui est information, évaluation de la motivation, un calendrier mixtionnel des conseils hygiéniques et éthiques, puis un traitement spécifique de la cause dominante, soit la décentralisation pour la forme polyurique, soit un conditionnement et alarme pour la forme à petite capacité visible, plus ou moins anticholinergique en fonction de la réponse au traitement. Les formes réfractaires peuvent justifier des associations thérapeutiques.